



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Tahun 2025

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki risiko terjadinya penularan infeksi baik kepada pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, maupun masyarakat sekitar. Infeksi yang terjadi di rumah sakit dapat berdampak pada meningkatnya angka kesakitan, lama rawat pasien, biaya pelayanan kesehatan, serta menurunnya mutu pelayanan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang terencana dan terintegrasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di lingkungan rumah sakit.

Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tenaga kesehatan dan staf rumah sakit dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Pedoman ini juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada berbagai regulasi dan standar yang berlaku, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh unit kerja di rumah sakit dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi secara konsisten dalam setiap kegiatan pelayanan kesehatan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pedoman ini di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.



LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Kerja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Rumah Sakit Prima Husada
Tahun 2025

Disusun oleh :
Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan

(Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.)

Disetujui oleh :
Authorized Person

(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.)



TIM PENYUSUN

PEDOMAN KERJA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

PENGARAH

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Pelaksana

2. Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.
3. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
4. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.
5. Dhea Ayu Puspita, S.Kep., Ns
6. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md. Kep.
7. Leni Narulita, S.Kep., Ns.
8. Isna Setya Wati, S.Kep., Ns.
9. Ida Nihayatul Afifa, S.Kep., Ns.
10. Lailiyatur Rofiqo, S.Tr. Keb
11. Sariayu, A.Md.Kep.
12. Durryyyatin Nabila, Am.Md.Kep.
13. Kikis Setyawati, A.Md.Kep
14. Muhammad Akhwanudin, S.Kep., Ns
15. Aulya Wahyuningrum R.D., A.Md.Kes
16. Ilham Eka Novianto Putro, A.Md.Kep
17. Ledyna Astri Oktasari, S.Farm.Apt.
18. Agistia Zalfa Nasihah, S.M
19. Dewi Shinta Bela, A.Md.RMIK
20. Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz
21. Iqbal Zakarsih
22. Mohammad Fa'is Yamani

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 935.170/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025

TENTANG
PEDOMAN KESEHATAN LINGKUNGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | <div><div>a.</div><div>b.</div><div>c.</div><div>d.</div></div> <div>bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta menjamin keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat di lingkungan rumah sakit, perlu dilakukan pengelolaan kesehatan lingkungan rumah sakit yang aman, sehat, dan berkelanjutan;</div> <div>bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta penularan penyakit yang dapat timbul dari aktivitas pelayanan kesehatan, diperlukan pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit yang meliputi pengelolaan air bersih, limbah padat dan cair, kualitas udara, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta sanitasi makanan dan minuman;</div> <div>bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lingkungan rumah sakit, perlu disusun Pedoman Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;</div> <div>bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Pedoman Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.</div> |
| Mengingat | : | <div><div>1.</div><div>2.</div><div>3.</div><div>4.</div><div>5.</div><div>6.</div><div>7.</div><div>8.</div><div>9.</div><div>10.</div><div>11.</div><div>12.</div><div>13.</div></div> <div>Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</div> <div>Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;</div> <div>Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;</div> <div>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;</div> <div>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27/MENKES/PER/I/2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;</div> <div>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit</div> <div>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Kesehatan Lingkungan RS ;</div> <div>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan</div> <div>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehan;</div> <div>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;</div> <div>Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit</div> <div>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</div> <div>Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 059.1/RSPHS/I-KEP/DIR/I/2022 tentang Struktur</div> |



- Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;
14. Keputusan Direktorat Jendral No HK.02.02.D.43961.2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 15. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1041.21/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, dan nyaman bagi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit.
- (2) Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah medis dan domestik, pengendalian serangga dan tikus, pengelolaan sanitasi makanan, serta pengawasan kualitas udara dan ventilasi.
- (3) Tingkat resiko terjadinya penularan penyakit
 - a. Area resiko rendah (instalasi gizi, ruang perkantoran dan non medis)
 - b. Area resiko sedang (rawat inap, poliklinik, farmasi, kamar jenazah, radiologi)
 - c. Area resiko tinggi (ICU, PICU, NICU, Ruang operasi, isolasi, VK)

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Kegiatan penyehatan ruang bangunan dan halaman
 - a. Inspeksi fisik ruang, bangunan dan halaman
 - b. Membuat SPO
 - c. Riview prosedur terkait dengan penyehatan ruang bangunan dan halaman
 - d. Evaluasi pelaksanaan
- (2) Penyehatan Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman adalah upaya pengawasan, perlindungan dan peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi pangan siap saji agar mewujudkan kualitas pengelolaan pangan yang sehat, aman dan selamat.
- (3) Penyehatan air adalah upaya penanganan kualitas dan kuantitas air di rumah sakit yang terdiri dari air untuk keperluan hygiene sanitasi, air minum dan air.
- (4) Pengelolaan limbah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme pathogen, bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif.
- (5) Pengelolaan tempat pencucian linen adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana

- penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan meja setrika.
- (6) Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya yang biasa disebut dengan vector, merupakan masalah rutin yang ada di rumah sakit.
 - (7) Perlindungan radiasi upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan resiko atas bahaya radiasi, dengan melakukan kegiatan pemantauan, investigasi, dan mitigasi pada sumber, media lingkungan dan manusia yang terpajan atau alat yang mengandung radiasi
 - (8) Promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka

BAB II

STANDART KETENAGAAN DAN FASILITAS

Pasal 3

Sumber Daya Manusia

- (1) Kualifikasi sumberdaya manusia pengendali lingkungan terdiri dari
 - a. Penanggung jawab sanitas
 - b. Pelaksana
- (2) Pengaturan jaga
 - a. Jam dinas penanggungjawab kesehatan lingkungan pada pukul 08.00-16.00 WIB
 - b. Jam dinas pelaksana kesehatan lingkungan pada pukul 06.00-15.00 WIB
- (3) Standart fasilitas
 - a. Ruang Kantor
 - b. IPAL
 - c. TPS Limbah B3
 - d. TPS Limbah Domestik
 - e. Gudang Chemical
 - f. Kamar Mandi
- (4) Peralatan APD
 - a. Masker
 - b. Apron/gaun
 - c. Sepatu booth
 - d. Pelindung wajah
 - e. Tutup kepala
 - f. Sarung tangan karet
 - g. Handscone
 - h. Google
 - i. Ear plug

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 4

Komitmen pimpinan tertinggi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur terkait penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan rumah sakit.

Pasal 5

Perencanaan dan Organisasi

- (1) Penyiapan program kerja Penyehatan Lingkungan mengacu pada hasil analisis risiko kesehatan lingkungan

- dan atau meliputi seluruh aspek kesehatan lingkungan.
- (2) Program kerja yang disusun berupa program kerja tahunan yang dapat dijabarkan dalam program kerja per triwulanan dan atau per semester.
 - (3) Susunan program kerja mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Direktur bersama dengan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
 - (4) Program kerja dilakukan monitoring dan evaluasi, ditindaklanjuti, dianalisa dan disusun laporan.

Pasal 6

Pelatihan Kesehatan Lingkungan

Program Pelatihan bagi staf unit penyehatan lingkungan bekerjasama dengan unit pengembangan SDM RS Prima Husada Sukorejo, berdasarkan standart kurikulum di bidang kesehatan lingkungan

BAB IV

TATA LAKSANA PENGELOLAAN

Pasal 7

Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman

- (1) Pemeliharaan kebersihan ruang bangunan dan halaman ini, dilakukan oleh pihak ke tiga/outshousing setiap hari.
- (2) Pemantauan dan pengawasan harian dilakukan oleh *House Keeping*.
- (3) Pelaksanaan inspeksi sanitasi ruangan berdasarkan area resiko dilakukan setiap bulan oleh petugas sanitasi

Pasal 8

Penyehatan Higien Sanitasi Makanan dan Minuman

- (1) Pemeriksaan usap dubur penjamah dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemeriksaan usap peralatan makanan dan uji kualitas makanan, dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemantauan dan pengawasan inspeksi sanitasi tempat pengelolaan makanan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 9

Penyehatan Air

- (1) Pemeliharaan kebersihan tandon air, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan kualitas air bersih, meliputi air sumur, air tandon, kran dapur, kran OK.
- (3) Pemeliharaan kebersihan dan perawatan unit Aquabidest dilakukan 2 (dua) minggu sekali.
- (4) Penggantian filter unit RO dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Penggantian media filtrasi dan membran, dilakukan maksimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penggantian bola lampu ultraviolet dilakukan secara icidensial.
- (7) Perawatan komponen penunjang unit aquabidest, dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- (8) Pemeriksaan kualitas air minum dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Limbah di rumah sakit meliputi pengelolaan terhadap limbah padat domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah cair dan limbah gas serta upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan risiko atas bahaya radiasi.

Pasal 11

Pengelolaan Laundry

- (1) Pemeriksaan usap linen bersih laundry dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan laundry dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 12

Penyehatan Udara

- (1) Kualitas udara ruangan harus selalu dipelihara agar tidak berbau, tidak mengandung debu dan gas, termasuk debu asbestos yang melebihi ketentuan.
- (2) Seluruh ruangan di rumah sakit didesain agar memenuhi ketentuan penghawaan ruangan, terutama ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, ruang intensif, ruang isolasi, perawatan bayi, laboratorium, ruang penyimpanan B3, dan ruangan lain yang memerlukan persyaratan khusus.
- (3) Pengukuran mikrobiologi udara dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan laboratorium dan peralatan ukur yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh laboratorium luar yang telah terakreditasi secara nasional.
- (4) Pemantauan kualitas udara ruang minimal 1 (satu) kali.

Pasal 13

Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

- (1) Pelaksanaan pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya dilakukan setiap hari dengan system surveilans oleh pihak ke tiga.
- (2) Pencatatan kegiatan surveilans, pencegahan dan pemberantasan serangga tikus dan binatang pengganggu lainnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
- (3) Pengendalian vector dan binatang pengganggu lainnya, bekerjasama dengan pihak Ke tiga.

Pasal 14

Pengawasan dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi

- (1) Persyaratan Kesehatan Lingkungan Dekontaminasi melalui Sterilisasi dan Desinfeksi.
- (2) Penyimpanan peralatan yang telah disterilkan harus ditempatkan pada tempat (lemari) khusus atau ruangan khusus.
- (3) Disinfektan harus memenuhi kriteria tidak merusak peralatan maupun orang.
- (4) Penggunaan disinfektan harus sesuai petunjuk penggunaan yang berlaku.
- (5) Sterilisasi harus menggunakan sterilan yang ramah lingkungan

Pasal 15

Pengawasan Rumah Sakit Hijau dan Sehat

Pengawasan rumah sakit ramah lingkungan merupakan kegiatan

pengendalian penggunaan berbagai sumber daya alam dan lingkungan dan sumber-sumber pencemaran lingkungan di rumah sakit yang dapat mempengaruhi perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga tercipta rumah sakit yang hijau, sehat, efisien dan ramah lingkungan.

BAB V LOGISTIK

Pasal 16

Logistik merupakan segala sesuatu baik sarana, prasarana dan semua barang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bidang Penyehatan Lingkungan dalam rangka pelaksanaan pelayanan di rumah sakit.

BAB VI KESELAMATAN PASIEN DAN KARYAWAN

Pasal 17

Keselamatan Pasien

Adapun keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;

- a. Insiden lantai licin akibat di pel.
- b. Insiden needle stick injury/tertusuk alat.
- c. Tajam lainnya.
- d. Insiden risiko plafon runtuh akibat rayap
- e. Insiden risiko kabel rusak akibat dimakan tikus.
- f. Insiden risiko IPAL yang sudah tidak sesuai dengan beban.
- g. Insiden risiko tercampurnya sampah infeksius dan non infeksius.
- h. Insiden risiko ketidaknyamanan/kerusakan kamar mandi.
- i. Insiden risiko tanamam rusak/mati.

Pasal 18

Keselamatan Karyawan

Adapun keselamatan karyawan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;

- a. Melakukan cuci tangan sesuai dengan standart
- b. Kepatuhan penggunaan APD

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Pasal 19

- (1) Potensi risiko pada petugas bagian penyehatan lingkungan dalam kesehatan kerja
 - a. Fisik
 - b. Ergonomi
 - c. psikososial
- (2) Upaya pengendalian atau pengurangan risiko yang dapat berdampak kepada petugas dengan cara penambahan peralatan kerja, APD, Vaksinasi dan pengaturan jadwal kerja.

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pasal 20

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan

indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Setiap tenaga medis maupun non medis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit wajib mengikuti Pedoman Kesehatan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 22

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 01 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada.



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR 935.170/RSPHS/I-
PER/DIR/XI/2025
TENTANG
PEDOMAN KESEHATAN LINGKUNGAN

PEDOMAN KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Aktivitas pelayanan kesehatan menghasilkan berbagai jenis limbah seperti limbah medis, limbah domestik, limbah cair, serta potensi pencemaran udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit yang sehat, aman, dan nyaman bagi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat sekitar rumah sakit. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah medis dan domestik, pengendalian serangga dan tikus, pengelolaan sanitasi makanan, serta pengawasan kualitas udara dan ventilasi.

Upaya kesehatan lingkungan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini diperkuat melalui pengaturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan diberbagai kegiatan diseluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Pedoman Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sebagai acuan bagi seluruh unit dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan rumah sakit.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan di rumah sakit yang menjamin kesehatan baik dari aspek fisik, kimia, biologi, radioaktivitas maupun sosial bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit serta mewujudkan rumah sakit ramah lingkungan;

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas media lingkungan dan mengendalikan risiko kesehatan;
2. Sebagai acuan dalam meningkatkan lingkungan rumah sakit yang dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan, keamanan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan hidup; dan
3. Sebagai acuan dalam mendukung terwujudnya manajemen pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan yang baik di rumah sakit

1.3 Ruang Lingkup Pengelolaan

Ruang lingkup pengelolaan penyehatan lingkungan di RS Prima Husada Sukorejo meliputi;

1.3.1 Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman

Penyehatan ruang bangunan dan halaman dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi yang nyaman, bersih dan sehat di lingkungan rumah sakit agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berupa terjadinya infeksi nosokomial baik terhadap pasien, pengunjung dan juga karyawan rumah sakit. Kondisi ruang bangunan ini, sangat dipengaruhi oleh kualitas udara, keadaan bangunan dan pengaturan pengisian atau penggunaan ruang itu sendiri. Ruang bangunan dan halaman rumah sakit adalah semua ruang/unit dan halaman yang ada di dalam batas pagar rumah sakit (bangunan fisik dan kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan rumah sakit, yang dikelompokkan berdasarkan tingkat/kriteria resiko terjadinya penularan penyakit, yaitu:

1. Area Resiko Rendah
Meliputi: instalasi gizi, ruang perkantoran dan non medis lain
2. Area Resiko Sedang
Meliputi: Bangsal Rawat Inap, Poliklinik, Farmasi, Ruang Jenazah, Radiologi, CSSD dan laundry, dan Laboratorium
3. Resiko Tinggi
Meliputi: ICU, PICU, NICU, Ruang Operasi, Hemodialisa Ruang Isolasi, VK

Kegiatan penyehatan ruang bangunan dan halaman merupakan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pemantauan suatu keadaan atau kondisi ruang bangunan dan halaman yang bebas dari bahaya atau resiko minimal untuk terjadinya infeksi nosokomial dan masalah kesehatan keselamatan kerja.

Kegiatan penyehatan ruang bangunan dan halaman tersebut, antara lain:

1. Inspeksi fisik ruang, bangunan dan halaman, meliputi:
 - a. Kebersihan ruang, bangunan dan halaman
 - b. Konstruksi ruang, bangunan dan halaman
 - c. Penataan ruangan
 - d. Kualitas udara ruangan
 - e. Pencahayaan
 - f. Suhu, kelembapan dan tekanan udara
 - g. Kebisingan
 - h. Fasilitas sanitasi rumah sakit
2. Membuat SPO pengambilan sampel mikrobiologi (swab) ruangan
3. Riview prosedu terkait dengan penyehatan ruang bangunan dan halaman
4. Evaluasi pelaksanaan penyehatan ruang bangunan dan halaman

1.3.2 Penyehatan Hygien Sanitasi Makanan dan Minuman

Penyehatan Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman adalah upaya pengawasan, perlindungan dan peningkatan kualitas hygiene dan sanitasi pangan siap saji agar mewujudkan kualitas pengelolaan pangan yang sehat, aman dan selamat. Untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan penyehatan pangan siap saji dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, maka harus memperhatikan dan mengendalikan faktor risiko keamanan pangan siap saji sebagai berikut:

1. Tempat Pengolahan Pangan: Inspeksi sanitasi tempat pengolahan makanan
2. Peralatan masak
 - a. Inspeksi sanitasi peralatan makanan, meliputi bahan, fungsi, cara pembersihan dan cara penyimpanan
 - b. Membuat SPO pemeriksaan kualitas peralatan makanan (uji swab)
3. Penjamah Pangan
 - a. Membuat SPO tentang persyaratan seorang penjamah makanan.
 - b. Membuat SPO pemeriksaan kesehatan bagi pemnjamah makanan
4. Kualitas Pangan
 - a. Inspeksi sanitasi makanan mulai dari bahan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan dan penyajian
 - b. Membuat SPO pemeriksaan kualitas makanan

- c. Penyajian Pangan : Cara penyajian pangan harus terhindar dari pencemaran dan bersih, Penyajian dilakukan dengan perilaku penyaji yang sehat dan berpakaian bersih

1.3.3 Penyehatan air

Penyehatan air adalah upaya penanganan kualitas dan kuantitas air di rumah sakit yang terdiri dari air untuk keperluan hygiene sanitasi, air minum dan air untuk pemakaian khusus agar dapat menunjang kesinambungan pelayanan di rumah sakit. Untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan air dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, maka harus dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Inspeksi sanitasi sarana air bersih dan air minum rumah sakit
2. Pengambilan, pengiriman dan pemeriksaan sampel air
3. Analisis hasil pemeriksaan air
4. Perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan point 1, 2 dan 3 di atas
5. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan

1.3.4 Pengelolaan limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen, bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit berasal dari limbah berbagai unit/instalasi yang ada di rumah sakit. Berdasarkan bentuk fisiknya, maka limbah rumah sakit dapat dibedakan yaitu:

1. Limbah padat
Adalah semua limbah yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari:
 - a. Limbah padat non medis
Adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
 - b. Limbah padat medis
Adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
2. Limbah cair
Adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam pengendalian pencemaran air, pihak rumah sakit diwajibkan untuk membuang limbah cairnya sesuai baku mutu lingkungan. Adapun parameter limbah cair yang perlu diolah adalah BOD, COD, TSS, NH₃ bebas, suhu, pH dan PO₄, sesuai dengan persyaratan baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Kegiatan Pengelolaan Limbah Cair, antara lain:
 - a. Monitoring kebersihan saluran air limbah, bak control dan pre treatment
 - b. Mengukur debit limbah cair yang masuk ke IPAL setiap hari
 - c. Memantau kualitas effluent limbah cair secara fisika-kimia sebulan sekali
 - d. Membuat SPO pemantauan kualitas effluent limbah cair (uji petik) setiap 3 bulan sekali
3. Limbah gas
Adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti incinerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Limbah gas/emisi dapat berupa makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain yang dihasilkan dari kegiatan yang masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Kegiatan pengelolaan limbah gas, meliputi:
 - a. Membuat SPO pemantauan limbah gas berupa NO₂, SO₂, logam berat, dan dioksin yang dilakukan 1 (satu) kali setahun
 - b. Monitoring suhu pembakaran minimum 1.000°C untuk pemusnahan bakteri patogen, virus, dioksin, dan mengurangi jelaga

- c. Melengkapi peralatan untuk mengurangi emisi gas dan debu
- d. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu

1.3.5 Pengelolaan tempat pencucian linen

Laundry rumah sakit adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan meja setrika. Di tempat pencucian/laundry, penumpukan-penumpukan linen kotor dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi para pekerja laundry dan juga dapat mengotori linen-linen yang sudah bersih. Kegiatan pengelolaan tempat pencucian linen, adalah sebagai berikut:

1. Inspeksi proses pengelolaan linen mulai dari pengumpulan, penerimaan, pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan dan distribusi/pengangkutan.
2. Monitoring penggunaan jenis deterjen dan desinfektan untuk proses pencucian yang ramah lingkungan agar limbah cair yang dihasilkan mudah terurai oleh lingkungan
3. Membuat SPO pemeriksaan kualitas linen bersih yaitu standar kuman bagi linen bersih setelah keluar dari proses tidak mengandung 6×10^3 spora spesies *Bacillus* per inci persegi

1.3.6 Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya

Serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya yang biasa disebut dengan vector, merupakan masalah rutin yang ada di rumah sakit. Vektor (serangga dan tikus), dalam program sanitasi rumah sakit adalah semua jenis serangga dan tikus yang dapat menularkan beberapa penyakit tertentu, merusak bahan pangan di gudang dan peralatan instalasi rumah sakit. Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya berguna untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan mencegah timbulnya kerugian ekonomi akibat dari rusaknya bahan pangan dan alat-alat rumah sakit seperti linen, peralatan kantor dan lain sebagainya.

Kegiatan pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengukur kepadatan lalat dan jentik aedes sp yang diamati melalui indeks container (harus nol)
2. Inspeksi langsung lubang-lubang tanpa kawat kasa
3. Membasmi tikus. Kecoak dan kucing

1.3.7 Perlindungan radiasi

Radiasi adalah emisi dan penyebaran energy melalui ruang (media) dalam bentuk gelombang elektromagnetik/partikel/elementer dengan kinetic yang sangat tinggi yang dilepaskan dari bahan atau alat radiasi yang digunakan oleh instalasi di rumah sakit. Pengamanan dampak radiasi adalah upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan resiko atas bahaya radiasi, dengan melakukan kegiatan pemantauan, investigasi, dan mitigasi pada sumber, media lingkungan dan manusia yang terpajan atau alat yang mengandung radiasi. Kegiatan perlindungan radiasi tersebut antara lain:

1. Pemantauan, investigasi dan mitigasi petugas, lingkungan dan peralatan radiologi
2. Membuat SPO pemeriksaan kesehatan bagi petugas/masyarakat yang terpajan radiasi.

1.3.8 Promosi kesehatan

Promosi kesehatan adalah suatu proses untuk memungkinkan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Promosi hygiene dan sanitasi adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi rumah sakit kepada pasien/keluarga pasien, pengunjung, karyawan baru maupun karyawan lama serta masyarakat sekitarnya agar mengetahui, memahami, menyadari, dan mau membiasakan diri berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi rumah sakit dengan benar. Promosi kesehatan lingkungan adalah penyampaian pesan tentang yang berkaitan dengan perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang biasa disebut dengan PHBS yang sasarannya ditujukan kepada karyawan.

1.4 Batasan Operasional

1. Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman: menciptakan suatu kondisi yang nyaman, bersih, dan sehat di lingkungan rumah sakit agar tidak menimbulkan dampak negative yang berupa terjadinya infeksi nosokomial baik terhadap pasien, pengunjung dan juga karyawan rumah sakit

2. Ruang Bangunan dan halaman rumah sakit: semua ruang/unit dan halaman yang ada di dalam batas pagar rumah sakit (bangunan fisik dan kelengkapannya) yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan rumah sakit.
3. Makanan dan Minuman di rumah sakit: semua makanan dan minuman yang disajikan dari instalasi gizi rumah sakit untuk pasien dan karyawan, makanan dan minuman yang dijual di dalam lingkungan rumah sakit atau makanan dan minuman yang dibawa dari luar rumah sakit.
4. Air minum: air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Air Bersih: air yang dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan dapat diminum apabila dimasak.
6. Limbah Padat Non Medis: limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit di luar medis yang berasal dari instalasi gizi, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Limbah Padat Medis: limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah container bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
7. Limbah Cair: semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan.
8. Limbah Gas: semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti incinerator, instalasi gizi, perlengkapan generator anastesi, dan pembuatan obat sitotoksik
9. Laundry: tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana penunjangnya berupa mesin cuci, alat dan disinfektan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan meja setrika.
10. Pengendalian serangga, tikus dan binatang Pengganggu: upaya untuk mengurangi populasi serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya sehingga keberadaannya tidak menjadi vector penularan penyakit.
11. Dekontaminasi: upaya mengurangi dan atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan dan ruang melalui pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimiawi.
12. Desinfeksi: upaya untuk mengurangi/menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen, penyebab penyakit (tidak termasuk spora) dengan cara fisik dan kimia
13. Sterilisasi: upaya untuk menghilangkan semua mikroorganisme dengan cara fisik dan kimia
14. Radiasi: emisi dan penyebaran energy melalui ruang (media) dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel – partikel atau elementer dengan kinetik yang sangat tinggi yang dilepaskan dari bahan atau alat radiasi yang digunakan oleh instalasi di rumah sakit.
15. Pengamanan Dampak Radiasi: upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan risiko atas bahaya radiasi, dengan melakukan kegiatan pemantauan, investigasi, dan mitigasi pada sumber, media lingkungan dan manusia yang terpajan atau yang mengandung radiasi.
16. Promosi hygiene dan sanitasi: penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi rumah sakit kepada pasien/keluarga pasien, pengunjung, karyawan baru ataupun karyawan lama serta masyarakat sekitarnya agar mengetahui, memahami, menyadari dan mau membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi rumah sakit dengan benar.
17. Promosi kesehatan lingkungan: penyampaian pesan tentang yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat yang biasa disebut dengan PHBS yang sasarannya ditujukan kepada karyawan.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN DAN FASILITAS

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Nama Jabatan	Kualifikasi		Jumlah Kebutuhan (orang)
	Pendidikan	Sertifikasi	
Penanggung Jawab Sanitasi	S1 Kesehatan Masyarakat		1
Pelaksana	SMA		3
Jumlah			4 orang

2.2 Distribusi Ketenagaan

1. Penanggung Jawab Sanitasi : 1 orang
2. Pelaksana : 3 orang

2.3 Pengaturan Jaga

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo di bagian penyehatan lingkungan memiliki 4 orang tenaga, yang terdiri atas ;

1. Penanggung jawab sanitasi : 1 orang
2. Pelaksana : 3 orang

Jabatan	Dinas	Jam Kerja
Penanggung jawab sanitasi	Pagi	Pukul 08.00 – 16.00 WIB
Pelaksana	Pagi 1	Pukul 06.00 – 14.00 WIB
	Pagi 2	Pukul 06.00 – 13.00 WIB
	Middle	Pukul 07.00 – 15.00 WIB

2.4 Standart Fasilitas

2.4.1 Ruangan, Luas dan Fungsi

Table 2.4.1 Ruangan, luas dan fungsi

No	Nama Ruang	Fungsi
1	Ruang Kantor	Ruang perkantoran dan administrasi
2	IPAL	Untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit
3	TPS LIMBAH B3	Untuk menyimpan sampah B3 dan infeksius sementara
4	TPS LIMBAH DOMESTIK	Untuk menyimpan sampah domestic sementara
5	Gudang Chemical	Untuk menyimpan chemical kebersihan
6	Kamar mandi	Bersih-bersih

2.4.2 Peralatan Kerja, Mesin/Peralatan/Sarana Lain

Table 2.4.2 Peralatan Kerja, Mesin/Peralatan/Sarana Lain

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	IPAL	1	Satu paket IPAL
2	Thermohigrometer	50	
3	TDS Digital	1	
4	pH meter digital	1	
5	Incenerator	1	Mesin off sejak Desember 2022

2.4.3 Peralatan Keselamatan (APD)

Table 2.4.3 Peralatan Keselamatan (APD)

No	Nama APD	Jumlah	Keterangan
1	Masker	1 boc	Baik
2	Apron / gaun	3 pcs	Baik
3	Sepatu booth	3 pcs	Baik
4	Pelindung wajah	1 buah	Baik
5	Tutup kepala	1 box	Baik
6	Sarung tangan karet	3 pcs	Baik
7	Handscone	1 box	Baik
8	Google	1 pcs	Baik
9	Ear plug	1 pcs	Baik

BAB III

KEBIJAKAN

3.1 Kebijakan Tertulis dan Komitemn Pimpinan Rumah Sakit

Komitmen pimpinan tertinggi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur terkait penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan rumah sakit. Kebijakan ini disosialisasikan ke seluruh staf/petugas Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

3.2 Perencanaan dan organisasi

1. Penyiapan program kerja Penyehatan Lingkungan mengacu pada hasil analisis risiko kesehatan lingkungan dan atau meliputi seluruh aspek kesehatan lingkungan.
2. Program kerja yang disusun berupa program kerja tahunan yang dapat dijabarkan dalam program kerja per triwulanan dan atau per semester.
3. Susunan program kerja mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh Direktur bersama dengan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
4. Program kerja dilakukan monitoring dan evaluasi, ditindaklanjuti, dianalisa dan disusun laporan.

Untuk memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, kegiatan kesehatan lingkungan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dokumen perijinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki regulasi internal yang dapat berupa pedoman, panduan, SOP, instruksi kerja yang diketahui oleh Direktur Utama sebagai pimpinan tertinggi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, serta dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan kegiatan kesehatan rumah sakit;
2. Mendokumentasikan seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman/panduan yang masih berlaku;
3. Menyusun analisi risiko kesehatan lingkungan mengacu pada standart yang berlaku umum dengan tujuan untuk mengetahui pemetaan sumber-sumber risiko kesehatan lingkungan dan prioritas pengelolaannya, menentukan upaya pencegahan dan upaya pengendalian resiko yang dilengkapi dengan metode pembobotan risiko dan peta risiko kesehatan rumah sakit;
4. Rencana strategis kesehatan lingkungan disusun berdasarkan pada perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal yang dapat berpengaruh pada kemampuan rumah sakit, yang menggambarkan tentang arah, tujuan serta pencapaian target rumah sakit;
5. Pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan mengacu pada pedoman dan program kerja yang telah ditetapkan;
6. Tindak lanjut yang dilaksanakan berdasarkan hasil temuan adalah berupa rekomendasi baik yang dilaksanakan unit kerja kesehatan lingkungan ataupun unit kerja lain yang terkait;
7. Laporan dibuat secara periodik, baik untuk kepentingan internal ataupun eksternal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

3.3 Pelatihan Kesehatan Lingkungan

Program Pelatihan bagi staf unit penyehatan lingkungan bekerjasama dengan unit pengembangan SDM RS Prima Husada Sukorejo, berdasarkan standart kurikulum di bidang kesehatan lingkungan.

3.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan dan dinas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan

BAB IV

TATA LAKSANA PENGELOLAAN

4.1 Penyehatan Ruang Bangunan dan Halaman

1. Pemeliharaan kebersihan ruang bangunan dan halaman ini, dilakukan oleh pihak ke tiga/outshousing setiap hari.
2. Pemantauan dan pengawasan harian dilakukan oleh *House Keeping*.
3. Pelaksanaan inspeksi sanitasi ruangan berdasarkan area resiko dilakukan setiap bulan oleh petugas sanitasi

4.2 Penyehatan Higien Sanitasi Makanan dan Minuman

1. Pemeriksaan usap dubur penjamah dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Pemeriksaan usap peralatan makanan dan uji kualitas makanan, dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan sekali.
3. Pemantauan dan pengawasan inspeksi sanitasi tempat pengelolaan makanan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sekali.

4.3 Penyehatan Air

1. Pemeliharaan kebersihan tandon air, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Pemeriksaan kualitas air bersih, meliputi air sumur, air tandon, kran dapur, kran OK.
3. Pemeliharaan kebersihan dan perawatan unit Aquabidest dilakukan 2 (dua) minggu sekali.
4. Penggantian filter unit RO dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
5. Penggantian media filtrasi dan membran, dilakukan maksimal 3 (tiga) tahun sekali.
6. Penggantian bola lampu ultraviolet dilakukan secara icidensial.
7. Perawatan komponen penunjang unit aquabidest, dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
8. Pemeriksaan kualitas air minum dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

4.4 Pengelolaan Limbah

Pengelolaan Limbah di rumah sakit meliputi pengelolaan terhadap limbah padat domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah cair dan limbah gas serta upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak radiasi melalui promosi dan pencegahan risiko atas bahaya radiasi.

4.4.1 Limbah Padat Domestik

Pengelolaan limbah padat domestik adalah upaya penanganan limbah padat domestik di rumah sakit yang memenuhi standar untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, kenyamanan dan keindahan yang ditimbulkan. Untuk menjamin pengelolaan limbah padat domestik dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Penanganan limbah rumah tangga, dilakukan dengan cara:
 - a. Tahap Pewadahan.
 - b. Tahap Pengangkutan.
 - c. Tahap Penyimpanan di TPS.
2. Pemilahan dan pengurangan dengan memisahkan jenis limbah organik dan limbah anorganik.
3. Penyediaan fasilitas penanganan limbah padat domestic, meliputi tempat sampah, trolley pengangkutan, TPS, Pemusnahan limbah dan fasilitas lainnya.
4. Penanganan vektor dan binatang pembawa penyakit limbah padat domestik.
5. Pembersihan lingkungan dan fisik.

4.4.2 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

1. Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan.
2. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluwarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan *fixer* dan *developer*, wadah cat bekas (untuk cat yang mengandung

zat toxic), wadah bekas bahan kimia, *catridge* printer bekas, film rontgen bekas, *motherboard* komputer bekas dan lainnya.

3. Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pihak pengolah atau penimbun limbah B3 dengan pengangkutan menggunakan jasa pengangkutan limbah B3 (*transporter* limbah B3), yang dilengkapi dengan perjanjian kerjasama secara *three parted* yang ditandatangani oleh pimpinan dari pihak rumah sakit, pihak pengangkut limbah B3 dan pengolah atau penimbun limbah B3.

4.4.3 Limbah Cair

1. Rumah sakit memiliki Unit Pengolahan Limbah Cair (IPAL) dengan teknologi yang tepat dan desain kapasitas olah limbah cair yang sesuai dengan volume limbah cair yang dihasilkan.
2. Limbah cair dari seluruh sumber dari bangunan/kegiatan rumah sakit harus diolah dalam Unit Pengolah Limbah Cair (IPAL) dan kualitas limbah cair efluennya harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dibuang ke lingkungan perairan.
3. IPAL harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.4.4 Limbah Radioaktif

1. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengolahan secara eksternal dilakukan melalui kerja sama dengan pihak pengolah atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki ijin.

4.4.5 Limbah Gas

Untuk mencapai pemenuhan pengamanan limbah gas dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit, maka dilaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Penaatan frekuensi pengambilan contoh limbah gas. Setiap rumah sakit harus melakukan pemeriksaan laboratorium emisi gas buang dan udara ambien luar dengan.
2. Pengujian emisi gas buang dilaksanakan oleh laboratorium yang telah terakreditasi nasional dan masih dalam masa berlaku.
3. Untuk menjaga agar kualitas gas emisi tetap memenuhi syarat. Upayakan mengganti bahan bakarnya dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
4. Penaatan pelaporan limbah gas. Rumah sakit menyampaikan laporan hasil uji/pengukuran laboratorium emisi gas buang dan udara ambien sesuai ketentuan.

4.5 Pengelolaan Laundry

1. Pemeriksaan usap linen bersih laundry dilakukan maksimal 6 (enam) bulan sekali.
2. Inspeksi sanitasi tempat pengelolaan laundry dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sekali.

4.6 Penyehatan Udara

1. Kualitas udara ruangan harus selalu dipelihara agar tidak berbau, tidak mengandung debu dan gas, termasuk debu asbes yang melebihi ketentuan.
2. Seluruh ruangan di rumah sakit didesain agar memenuhi ketentuan penghawaan ruangan, terutama ruang-ruang tertentu seperti ruang operasi, ruang intensif, ruang isolasi, perawatan bayi, laboratorium, ruang penyimpanan B3, dan ruangan lain yang memerlukan persyaratan khusus.
3. Pengukuran mikrobiologi udara dapat dilakukan secara mandiri menggunakan peralatan laboratorium dan peralatan ukur yang sesuai, atau dapat dilakukan oleh laboratorium luar yang telah terakreditasi secara nasional.
4. Pemantauan kualitas udara ruang minimal 1 (satu) kali.

4.7 Pengendalian vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

1. Pelaksanaan pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya dilakukan setiap hari dengan *system survey* oleh pihak ke tiga.

2. Pencatatan kegiatan surveilans, pencegahan dan pemberantasan serangga tikus dan binatang pengganggu lainnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
3. Pengendalian vector dan binatang pengganggu lainnya, bekerjasama dengan pihak Ke tiga.

4.8 Pengawasan Dekontaminasi melalui Desinfeksi dan Sterilisasi

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya berbagai jenis mikroorganisme penyakit menular yang dapat menginfeksi pasien, pengunjung dan staf rumah sakit. Untuk menjamin perlindungan kesehatan, maka mikroorganisme di rumah sakit perlu dicegah dan dikendalikan melalui upaya dekontaminasi. Dekontaminasi adalah upaya mengurangi dan/atau menghilangkan kontaminasi oleh mikroorganisme pada orang, peralatan, bahan, dan ruang melalui disinfeksi dan sterilisasi dengan cara fisik dan kimiawi. Cara dekontaminasi yang sering dipakai di rumah sakit adalah disinfeksi dan sterilisasi.

Untuk mengetahui upaya disinfeksi dan sterilisasi telah sesuai ketentuan dan persyaratan, maka harus harus memenuhi ketentuan penyelenggaraan kesehatan lingkungan dekontaminasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Dekontaminasi melalui Sterilisasi dan Desinfeksi.
2. Penyimpanan peralatan yang telah disterilkan harus ditempatkan pada tempat (lemari) khusus atau ruangan khusus.
3. Disinfektan harus memenuhi kriteria tidak merusak peralatan maupun orang.
4. Penggunaan disinfektan harus sesuai petunjuk penggunaan yang berlaku.
5. Sterilisasi harus menggunakan sterilan yang ramah lingkungan.

4.9 Pengawasan Rumah Sakit Hijau dan Sehat

Pengawasan rumah sakit ramah lingkungan merupakan kegiatan pengendalian penggunaan berbagai sumber daya alam dan lingkungan dan sumber-sumber pencemaran lingkungan di rumah sakit yang dapat mempengaruhi perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga tercipta rumah sakit yang hijau, sehat, efisien dan ramah lingkungan. Rumah sakit ramah lingkungan adalah model operasional kegiatan rumah sakit dengan berbasis pada pelayanan dengan mengedepankan kualitas dan keselamatan (*quality and safety*), efisiensi dan ramah lingkungan yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan kontribusi rumah sakit pada pencegahan perubahan iklim dan pemanasan global.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan saat ini perlu menerapkan konsep rumah sakit ramah lingkungan karena alasan menggunakan cukup banyak sumber daya alam dan lingkungan. Penggunaan listrik, air bersih, bahan bakar, dan lainnya yang tidak bijak dan sistem pengelolaannya yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan beban pencemaran pada alam dan lingkungan hidup. Mewujudkan rumah sakit ramah lingkungan dapat dilaksanakan antara lain dengan:

1. menyusun kebijakan tentang rumah sakit ramah lingkungan;
2. pembentukan tim rumah sakit ramah lingkungan;
3. pengembangan tapak/lahan rumah sakit;
4. penghematan energi listrik;
5. penghematan dan konservasi air;
6. penyehatan kualitas udara indoor;
7. manajemen lingkungan gedung;
8. pengurangan limbah;
9. pendidikan ramah lingkungan;
10. penyelenggaraan kebersihan ramah lingkungan; dan
11. pengadaan material ramah lingkungan

BAB V LOGISTIK

Logistik merupakan segala sesuatu baik sarana, prasarana dan semua barang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bidang Penyehatan Lingkungan dalam rangka pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Adapun prosedur yang perlu dilakukan dalam proses permintaan kebutuhan barang logistik yaitu:

1. Petugas Penyehatan Lingkungan menulis daftar permintaan barang pada blanko/form permintaan barang dan penginputan SIM RS
2. Blanko/form permintaan barang dicek dan ditandatangani oleh Penanggungjawab bidang Penyehatan Lingkungan.
3. Petugas penyehatan lingkungan menyerahkan form tersebut kepada Petugas Pengadaan.
4. Petugas Pengadaan menerima daftar permintaan barang.
5. Apabila barang telah disiapkan oleh bagian pengadaan, petugas penyehatan lingkungan mengambil barang tersebut setelah melakukan cek data dan barang yang diterima melalui SIM RS.
6. Apabila barang yang diterima sesuai dengan daftar permintaan, petugas menandatangani bukti serah terima barang.
7. Petugas penyehatan lingkungan menempatkan barang ke dalam lemari stok barang.
8. Untuk permintaan plastik limbah sesuai ukuran dan tebal yang telah dipersyaratkan oleh bagian penyehatan lingkungan.
9. Kebutuhan untuk bahan dan chemical hanya dapat dipenuhi dengan syarat bahwa bahan/chemical yang dipesan harus bersertifikat halal MUI dan terdapat MSDS (*Material Safety Data Sheet*)/Lembar keselamatan bahan.
10. Petugas penyehatan lingkungan menerima bahan *chemical* dari pengadaan melalui vendor, melakukan pengecekan barang dengan form penerimaan chemical sesuai daftar yang dipesan, menempatkan ke dalam gudang chemical sesuai identifikasi chemical, mencatat dalam *log book chemical*.

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN DAN KARYAWAN

6.1 Pengertian

Merupakan suatu system yang membuat asuhan pasien di Rumah Sakit menjadi lebih aman. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya di ambil.

6.2 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan keselamatan pasien (Patient Safety) :

1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit.
2. Meningkatnya akuntabilitas Rumah Sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunnya angka Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) di Rumah Sakit.
4. Terlaksananya program – program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).

6.3 Keselamatan Karyawan

Mencuci tangan merupakan aturan yang penting untuk mencegah penyebaran infeksi, langkah – langkahnya sebagai berikut :

1. Tuangkan Cairan anti septik / sabun ke telapak tangan secukupnya.
2. Gosokkan kedua telapak tangan.
3. Gosok punggung tangan dan sela – sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya.
4. Gosok kedua telapak tangan dan sela – sela jari.
5. Jari – jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci.
6. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggam tangan kanan dan lakukan sebaliknya.
7. Gosokkan dengan memutar ujung jari – jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
8. Bilas kedua tangan dengan air mengalir.
9. Keringkan kedua tangan dengan tissue.

Dengan memperhatikan 5 momen cuci tangan sebagai berikut,

1. Sebelum kontak dengan pasien
2. Sebelum melakukan tindakan aseptik
3. Setelah terkena cairan tubuh pasien
4. Setelah kontak dengan pasien
5. Setelah dari lingkungan pasien

6.4 Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien yang berada di Bidang Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sesuai kesepakatan bersama dalam rapat pimpinan adalah:

1. Insiden lantai licin akibat di pel.
2. Insiden needle stick injury/tertusuk alat.
3. Tajam lainnya.
4. Insiden risiko plafon runtuh akibat rayap
5. Insiden risiko kabel rusak akibat dimakan tikus.
6. Insiden risiko IPAL yang sudah tidak sesuai dengan beban.
7. Insiden risiko tercampurnya sampah infeksius dan non infeksius.
8. Insiden risiko ketidaknyamanan/kerusakan kamar mandi.
9. Insiden risiko tanamam rusak/mati.

Apabila terjadi salah satu insiden diatas maka kita perlu melakukan RCA atau FMEA bersama komite Mutu, Keselamatan Pasien dan Komite Keselamatan dan kesehatan kerja guna menganalisa fasilitas dan pemecahannya.

BAB VII

KESELAMATAN KERJA

Potensi risiko pada petugas bagian penyehatan lingkungan dalam kesehatan kerja diantaranya;

Tabel 7 Potensi Risiko Pada Petugas Penyehatan Lingkungan

Bahay Potensial	Lokasi	Pekerja Yang Paling Berisiko
Fisik		
a. Debu	Area Taman dan halaman	Petugas Kebersihan
b. Panas	Area Taman dan halaman	Petugas Kebersihan
c. Bising	Area IPAL	Operator IPAL
Kimia		
a. Disinfektan	Tempat penyimpanan B3	Petugas kebersihan, petugas Sanitasi
Ergonomi		
a. Pekerjaan yang dilakukan secara manual	TPS Limbah B3	Petugas yang menangani barang
b. Postur yang salah dalam melakukan pekerjaan	Semua area	Semua karyawan
c. Pekerjaan yang berulang	Semua area	Petugas Sanitasi
Psikososial		
Sering kontak dengan pasien, kerja bergilir, kerja berlebih, ancaman secara fisik	Semua area	Semua karyawan

Dari risiko yang ada sudah diupayakan pengendalian atau pengurangan risiko yang dapat berdampak kepada petugas dengan cara penambahan peralatan kerja, APD, Vaksinasi dan pengaturan jadwal kerja. Pengendalian ini dilakukan bersama antar unit dan komite yang terlibat didalamnya dengan penanggung jawab pada penyehatan lingkungan adalah penanggung jawab unit bersama kabag penyehatan lingkungan dalam penyusunan rencana kerja anggaran.

Pada assesment Risiko manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) dibagian penyehatan lingkungan di dapatkan Risk Register sebagai berikut,
Gambar 7.1 Risk Register

NO	KATEGORI RISIKO (KLINIS/ K3/ KEUANGAN/ OPERASIONAL/ REPUTASI)	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN ¹⁾	Unit yang Mengisi	AREA /LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO					PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT					PERINGKAT RISIKO (GAK PERLU DISI)	EVALUASI RISIKO APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO				RISIKO RESIDUAL				PEMILIK RISIKO ²⁾	TARGET WAKTU
						SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO		DAMPAK	PROBABILI TAS	CONCAT (D & P)	SKOR	URAIAN PENANGANAN RISIKO				PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILI TAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO					
1	Risiko K3	Pembersihan semua area outdoor RS	Untuk membersihkan semua area taman RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Taman	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 1	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)	sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Penggunaan APD (sarung tangan kerja karet, lucerna google, sepatu booth, masker)	3	4	33	12	2	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	1	3	4	CS Outdoor				
2	Risiko K3	Pembersihan semua area outdoor RS	Untuk membersihkan semua area taman RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Taman	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 2	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)	sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Penggunaan APD (sarung tangan kerja karet, lucerna google, sepatu booth, masker)	3	3	33	9	3	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	1	3	3	CS Outdoor				
3	Risiko K3	Pembersihan semua area outdoor RS	Untuk membersihkan semua area taman RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Taman	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 3	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)	sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Penggunaan APD (sarung tangan kerja karet, lucerna google, sepatu booth, masker)	3	5	35	15	1	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	3	6	1	CS Outdoor				
4	Risiko K3	Pembersihan semua area outdoor RS	Untuk membersihkan semua area taman RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Taman	Dikarenakan tidak berhati-hati ketika bekerja	R 4	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)	sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Dikarenakan tidak berhati-hati ketika bekerjakemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical (pestisida)sehingga staf dapat terpapar bahan kimia	Penggunaan APD (sarung tangan kerja karet, lucerna google, sepatu booth, masker)	3	3	32	6	4	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan KRS	Retensi risiko	3	1	3	2	CS Outdoor				

NO	KATEGORI RISIKO (KLINIS/ K3/ KEUANGAN/ OPERASIONAL)	NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS)	Tujuan KEGIATAN ¹⁾	Unit yang Mengisi	AREA / LOKASI	IDENTIFIKASI RISIKO					PENGENDALIAN YANG SUDAH ADA SAAT INI	ANALISA RISIKO INHERENT				EVALUASI RISIKO		ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO				RISIKO RESIDUAL			PEMILIK RISIKO/ TARGET WAKTU
						SEBAB	KODE RISIKO	RISIKO	DAMPAK	PERNYATAAN RISIKO		DAMPAK	PROBABILI TAS	CONCAT (D & P)	SKOR	PERINGKAT RISIKO (GAK PERLU DISI)	APAKAH PERLU PENANGANAN RISIKO ?	OPSI TEKNIK PENGENDALIAN RISIKO	URAIAN PENANGANAN RISIKO	PEMBIAYAAN RISIKO	DAMPAK	PROBABILI TAS	SKOR	PERINGKAT RISIKO	
1	Risiko K3	Pembersihan semua area di RS	Untuk membersihkan semua area yang berada di RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Semua Area RS	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 1	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemical	sehingga staf dapat terpapar penyakit dari pasien	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan cairan chemicalsehingga staf dapat tertular penyakit dari pasien	Penggunaan APD (handbooth)	3	4	33	12	2	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	1	3	4	Cleaning Service
2	Risiko K3	Pembersihan semua area di RS	Untuk membersihkan semua area yang berada di RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Semua Area RS	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 2	kemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan tubuh pasien	sehingga staf dapat terpapar penyakit dari pasien	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan staf terpapar dengan tubuh pasiensehingga staf dapat tertular penyakit dari pasien	Penggunaan APD (handbooth)	3	3	33	9	3	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	1	3	3	Cleaning Service
3	Risiko K3	Pembersihan semua area di RS	Untuk membersihkan semua area yang berada di RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Semua Area RS	Karena tidak menggunakan APD dengan tepat	R 3	kemungkinan menyebabkan pasien droplet dari pasien	sehingga staf dapat terpapar penyakit dari pasien	Karena tidak menggunakan APD dengan tepatkemungkinan menyebabkan pasien droplet dari pasiensehingga staf dapat tertular penyakit dari pasien	Penggunaan APD (masker)	3	5	35	15	1	ya	Reduksi kerugian (Mengurangi Dampak)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan PPI	Retensi risiko	3	3	6	1	Cleaning Service
4	Risiko K3	Pembersihan semua area di RS	Untuk membersihkan semua area yang berada di RS agar menjadi bersih dan nyaman	Cleaning Service	Semua Area RS	Dikarenakan tidak berhati-hati ketika bekerja	R 4	menyebabkan staf berisiko terpapar	sehingga mengakibatkan staf cedera	Dikarenakan tidak berhati-hati ketika bekerjamenyebabkan staf berisiko terpaparsehingga mengakibatkan staf cedera	Penggunaan APD (booth boots)	3	2	32	6	4	ya	Cegah kerugian (Mengurangi Probabilitas)	Penggunaan APD dengan tepat sekaligus supervisi dari KRU CS dan KRS	Retensi risiko	3	1	3	2	Cleaning Service

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit yaitu:

8.1 Defenisi Indikator adalah:

Adalah ukuran atau cara mengukur sehingga menunjukkan suatu indikasi. Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

8.2 Kriteria :

Adalah spesifikasi dari indikator.

8.3 Standar :

1. Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut.
2. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik.
3. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu.

8.4 Indikator Mutu

-
1. Kepatuhan cuci tangan
 2. Kepatuhan penggunaan APD
 3. Baku mutu limbah cair
 4. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai indikator RS

BAB IX PENUTUP

Pedoman Kesehatan Lingkungan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pengendalian lingkungan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh tenaga kesehatan dapat melaksanakan praktik pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip Kesehatan lingkungan sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit serta keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi pemerintah, serta kebutuhan rumah sakit.

Mengetahui
Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan



Ns. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.

Pasuruan, 01 November 2025
Menyetujui
Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep.